

NS

RAFAEL GALVÃO NUNES DE GAUTO

IDADE: 29

PESO: 140

ALTURA: 188

PROFISSÃO: Eng. mec.

SINTOMAS: Cansaço / Dor de garganta / Dor de / Acorda eng.

QUEIXAS: 4 AS / DM nega / Ansiedade / Depressão.

MEDICAMENTOS: Losartana / Citalopram

Dr. Alberto / Dr. Alessandra.

EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada 4x

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: S

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 7hs

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO (só alguns F.S.).

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: OX

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: III

IAH: 64.1

SPO2: 66%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Investigar

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

Dor nas costas mm.

Dr. Alberto

18/04/23 Início 5-9 cmH₂O (sem titulação).27/04/23 P = 7.1 cmH₂O * ajuste leve másc.

IAH = 1.4 e lev * ↑ umid. p/ S.

m. de uso: 7hs

fua

16/05/23

P = 6.7 cmH₂O - perc. 7.7 cmH₂O

IAH = 1.3 e lev

m. de uso: 4h 58'

Relata pressão excessiva (ajuste da máscara).

sem queixas.

fua.

20/06/23

P = 7.0 cmH₂O

IAH = 0.9

Fuga = 3.4 l/min

m. de uso: 7hs

fua.

31/08/23

P = 7.0 cmH₂O

IAH = 0.8 e lev

m. de uso: 6:30'

Bem adaptado

másc. 1x semana

fua.

21/10

23

P = 7.0 cmH₂O

m. de uso: 8h 37'

IAH = 1.5 e lev

Fuga = 12.5 l/min

fua.

18/01

24

P = 6.4

M. de uso: 7h

IAH = 0.5 e/h

Fuga = 8 lpm

Relata estar q muito
grande melhora do
quadro.

fua

25/03

24

P = 6.1 cmH₂O

IAH = 0.5 e/h

M. de uso: 6h

fuga = 1.2

Bem adaptado

fua

17/06

24

P = 6.1 cmH₂O

IAH = 0.4 e/h

M. de uso: 6h 15'

Relata melhora do quadro

fua

19/08

24

P = 5.8 cmH₂O

IAH = 0.6 e/h

M. de uso: 8h 14'

Fuga = 2.9 lpm.

fua Cláudia

16/12

24

P = 5.6 cmH₂O

IAH = 0.5 e/h

M. de uso: 5h 7'

fuga = 3.7 lpm

Relata estar dormindo pouco e
o CPAP

De: 30d usou 15d fua.

12/03

25

P = 6.0 cmH₂O

IAH = 0.6 e/h

M. de uso: 5h 20'

fuga = 16.3 lpm.

Relata esta dormindo pouco,
devido calor.

Oriento o uso constante.

fua.

28/05/25

P = 5.8 cmH₂O

IAH = 0.4 e/h

M. de uso: 5h 31'

fuga: 13.3 lpm

Oriento uso constante, incluir
atividade física

Mateia



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UNESP
Doutor em Ciências pela UNIFESP
CRM-SP: 69730

DRG. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

Rafael Galvão Nunes de Fauto

Solicito o aluguel ou venda do
CPAP para o tratamento da síndrome de
apnéia do sono.

Ele usou máscara nasal.
Pressão recomendada: 9cmH₂O.

Att,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

SJC, 5/4/23

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA
POLISSONOGRAFIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELTÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP: 69.730

CRM-SP: 62.858

NOME: Rafael Galvão Nunes de Gauto
 EXAME nº: 5282
 SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
 DATA: 07/12/2022
 IDADE: 28 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h40min e concluído às 06h42min. A latência para o sono foi de 9 minutos e a latência para o sono REM, de 253 minutos. O tempo total de sono foi de 399 minutos (06h39min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 82,7%. A distribuição do sono mostrou 24,9% de estágio 1, 44,7% de estágio 2, 10,5% de estágio 3 e 19,8% de sono REM. No período total de sono permaneceu 74,5 minutos em vigília, ocorreram 266 microdespertares (índice: 40/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 64,1/hora, sendo 16,8 apneia/hora e 47,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 64,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 90% e a mínima de 66%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (64,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (64,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM e no decúbito dorsal, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 84 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 9 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (253 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 82,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 40/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (24,9%; normal: 5%) e a redução do estágio 3 (10,5%; normal: 15-20%). As porcentagens dos estágios 2 (44,7%; normal: 45-55%) e REM (19,8%; normal: 20-25%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 8 (normal até 9; máxima: 24).

Assinatura do médico
 Data: 07/12/2022

Dr. Alberto Jorge
 Remesar Lopez
 Médico
 CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
 Diretor Técnico Médico
 CRM-SP 69.730



DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMIA

NOME: Rafael Galvão Nunes de Gauto
EXAME nº: 5282-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 30/01/2023
IDADE: 28 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h47min e concluído às 06h22min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o sono REM, de 251 minutos. O tempo total de sono foi de 473 minutos (07h53min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 91,8%. A distribuição do sono mostrou 12,8% de estágio 1, 33,3% de estágio 2, 26,8% de estágio 3 e 27,1% de sono REM. No período total de sono permaneceu 34,5 minutos em vigília, ocorreram 127 microdespertares (índice: 16,1/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 11/hora, sendo 1 apneia/hora e 10 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 11/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 94% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa shallow (Resmed®). A pressão final recomendada foi de 9 cm H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (11/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (11/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no início do exame, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 60; máxima: 86 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min) - ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 21h20min. A latência para o estágio REM estava alongada (251 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (91,8%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 16,1/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (12,8%; normal: 5%), 3 (26,8%; normal: 15-20%) e REM (27,1%; normal: 20-25%), e a redução do estágio 2 (33,3%; normal: 45-55%)

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

CONTA

1. DADOS DA LOCADORA
NOME: Faria e Matos Comércio
CNPJ: 13.181.386/0001-27
ENDEREÇO: Rua Santa Elza, 41,
CEP: 12249-600